

# Nietolerancja *niepewności* (IU)

Centralny mechanizm GAD wg modelu Dugasa: „nie umiem żyć, nie wiedząc”. Tu rozpoznajesz, jak działa u Ciebie.

**CZAS:** 25 min 1 sesja + dziennik 1 tydz.

**ŹRÓDŁO:** Dugas i wsp. (1998, 2007); Carleton (2016); IUS-12 (Carleton i wsp.)

## JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj **dwie twarze IU** (sekcja 01): poznawczą („muszę wiedzieć”) i behawioralną („muszę kontrolować”). Wypełnij **skrótowy IUS-12** (sekcja 02) — 12 pytań samooceny. Wypełnij **mapę swoich zachowań kontrolnych** (sekcja 03). Cel: zobaczyć, że za *różnymi* obszarami martwienia stoi **jeden wspólny mechanizm** — i to jego trzeba pracować, a nie każdej obawy osobno.

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Model Dugasa (jedna z trzech głównych teorii GAD) pokazuje, że pacjenci z GAD mają **specyficzny rodzaj niepokoju**: nie boją się konkretnych rzeczy — boją się *niewiedzy*. Nietolerancja niepewności (ang. *intolerance of uncertainty*, IU) działa jak alergia: każda informacja niepewna wywołuje reakcję lękową. Pacjent *nigdy* nie miał problemu z konkretnym tematem — ma problem z **niepewnością jako taką**. Pracujesz z IU → wszystkie tematy „same” się uspokajają.

## 01 Dwie twarze nietolerancji niepewności

### IU PROSPEKTYWNE — „MUSZĘ WIEDZIEĆ”

Komponent *poznawczy*: niepewność interpretowana jako **zagrożenie** samo w sobie.

„Nie wiem, więc coś jest nie tak.”  
„Muszę przewidzieć, co się stanie.”  
„Niewiedza = niebezpieczeństwo.”

Przejawy: **nadmierne martwienie**, googlowanie objawów, analizowanie scenariuszy, pytanie o opinie.

### IU INHIBICYJNE — „MUSZĘ KONTROLOWAĆ”

Komponent *behawioralny*: niepewność blokuje działanie, paraliżuje.

„Nie zacznę, dopóki nie będę pewien/pewna.”  
„Lepiej nic, niż coś niepewnego.”  
„Muszę mieć plan A, B i C zanim ruszę.”

Przejawy: **prokrastynacja**, perfekcjonizm, unikanie decyzji, ciągłe przekładanie.

## 02 Skrócona skala IUS-12 — oceń każde stwierdzenie 1–5

**Skala:** 1 = w ogóle nie pasuje · 2 = nieco · 3 = średnio · 4 = znacznie · 5 = bardzo pasuje. Wpisz cyfrę przy każdym pytaniu.

- |                                                                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1. Niepewność powstrzymuje mnie od działania.                          | <input type="checkbox"/> 2. Nieprzewidziane zdarzenia bardzo mnie denerwują.            |
| <input type="checkbox"/> 3. Niepewność sprawia, że nie mogę żyć normalnie.                      | <input type="checkbox"/> 4. Trudno mi tolerować niepewną przyszłość.                    |
| <input type="checkbox"/> 5. Niewiedza, co stanie się jutro, frustruje mnie.                     | <input type="checkbox"/> 6. Trudno mi działać bez wszystkich informacji.                |
| <input type="checkbox"/> 7. Niepewność czyni mnie podatnym na stres.                            | <input type="checkbox"/> 8. Zawsze chcę wiedzieć, co przyniesie przyszłość.             |
| <input type="checkbox"/> 9. Nie znoszę być zaskakiwany/-a.                                      | <input type="checkbox"/> 10. Najmniejsza niepewność może powstrzymać mnie od działania. |
| <input type="checkbox"/> 11. Powinienem/-am być w stanie wszystko zorganizować z wyprzedzeniem. | <input type="checkbox"/> 12. Jedna mała nieprzewidziana rzecz może zepsuć wszystko.     |

**Suma punktów:** \_\_\_\_ / 60  
*interpretacja niżej*

≤24: niskie IU · 25-35: umiarkowane · 36-47: wysokie · ≥48: bardzo wysokie (klinicznie istotne)

03

**Moje zachowania kontrolne** — co robię, gdy pojawia się niepewność?

- ☐ **Googluję** objawy, sytuacje, prognozy
- ☐ **Sprawdzam wielokrotnie** (drzwi, kuchenka, telefon)
- ☐ **Planuję nadmiernie** — plany A, B, C, D
- ☐ **Unikam nowości** — nowe miejsca, ludzie, sytuacje
- ☐ **Wcześniej wychodzę** „na wszelki wypadek”
- ☐ **Mentalne sprawdzanie** — w głowie przeglądam plan
- ☐ **Pytam o zapewnienia** bliskich („czy wszystko ok?”)
- ☐ **Wracam do wiadomości**, czytam wielokrotnie
- ☐ **Przekładam decyzje**, czekam aż będzie „pewność”
- ☐ **Robię listy do list**, kategoryzuję wszystko
- ☐ **Dopytuję ekspertów** (lekarz, prawnik, doradca) ponad miarę
- ☐ **Nie deleguję** — robię sam/-a, żeby mieć kontrolę

Każde z tych zachowań *krótkoterminowo* daje ulgę (mniej niepewności). *Długoterminowo* wzmacnia IU — bo mózg uczy się, że nie da się żyć z niepewnością. Cel terapii: **stopniowa ekspozycja na niepewność bez tych zachowań** (narzędzie #8 „Eksperymenty na nietolerancję niepewności”).

04

**Wnioski**

MÓJ WYNIK IUS-12 (SKALA)

— co o mnie mówi?

KTÓRE 2–3 ZACHOWANIA KONTROLNE SĄ U MNIE NAJSILNIEJSZE?

CO BYŁOBY PIERWSZYM MAŁYM KROKIEM, BY JE ZMNIEJSZYĆ?

— np. „nie googluję objawów przez tydzień”

**Kluczowy wgląd:** IU jest *transdiagnostycznym* mechanizmem — wspólnym dla GAD, OCD, fobii społecznej, hipochondrii. Pracujesz z IU — łagodzisz wszystkie te zaburzenia jednocześnie. Carleton (2016) zaproponował, że IU może być **centralnym lękiem ludzkim**, leżącym pod wszystkimi specyficznymi obawami. Następny krok: *narzędzie #8 — Eksperymenty na nietolerancję niepewności*.